

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

1. En el caso de que la paciente tenga infección de orina, ¿qué pruebas del sistemático de orina deberían dar positivos?
A) Glucosa y nitritos
B) Hematíes y glucosa
C) Leucocitos y nitritos
D) Glucosa y cuerpos cetónicos
2. Una de las neveras de transporte, según marca la pantalla del termómetro incorporado, es de 39°C, porque el vehículo ha tenido un retraso de 4 horas en la entrega, por fallo mecánico. Dicha nevera traía orinas para siembras. ¿Qué tiempo debe transcurrir desde la recogida hasta su procesamiento?
A) El tiempo no se tiene en cuenta.
B) 8 horas.
C) El mínimo y si no conservar en nevera como máximo 24 horas.
D) Aproximadamente 3 horas.
3. ¿Qué conservante no se utiliza para mantener las muestras de orina?
A) Ac. bórico.
B) Ac. acético.
C) Fluoruro sódico.
D) Oxalatonaf.
4. Se conoce como recuento de Addis:
A) Un método de numeración cualitativo de los hematíes, leucocitos y cilindros en una muestra de orina.
B) Un método de enumeración cuantitativo de los hematíes, leucocitos y cilindros en una muestra de orina.
C) Un método cualitativo para detectar cilindros.
D) Un método para determinar cualitativamente hematuria.
5. La determinación de nitritos en orina nos sirve para detectar:
A) Bacteriuria.
B) Proteinuria.
C) Nitratos.
D) Oliguria.
6. Los cilindros con mayor índice de refracción son:
A) Hialinos.
B) Bacterianos.
C) Hemáticos.
D) Céreos.
7. La reacción de color de Jaffé es la adecuada para la determinación de:
A) Bilirrubina.
B) Ácido úrico.
C) Creatinina.
D) Albúmina.
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la formación de orina es falsa?
A) Las células tubulares tienen la facultad de excretar algunas sustancias.
B) La filtración glomerular es un proceso físico.
C) La reabsorción se produce por medio de mecanismos de transporte tanto pasivos como activos.
D) La reabsorción es la primera etapa en la formación de orina.
9. Las pruebas de función renal tienen como fin:
A) Detectar la presencia de una lesión en el riñón.
B) Localizar el lugar de la lesión.
C) Cuantificar el grado de la lesión.
D) Todas son ciertas.
10. Los cilindros hemáticos:
A) Están compuestos fundamentalmente de proteínas sin inclusiones.
B) Son un signo de lesión a nivel del parénquima renal.
C) Su presencia en el sedimento no tiene



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

significación clínica.

D) Son los cilindros más abundantes de la orina.

11. La aparición de nitritos en orina indica

A) Diabetes.

B) Crecimiento bacteriano.

C) Hemólisis.

D) Ayuno prolongado.

12. El método de Biuret se utiliza para la determinación de:

A) Glucosa.

B) Lípidos.

C) Proteínas.

D) Electrolitos.

13. Respecto a la presencia de hematíes dismórficos en la orina:

A) Suele deberse a errores preanalíticos.

B) Su presencia en un % elevado indica un origen glomerular de la hematuria.

C) Su presencia en un % elevado indica hematuria no glomerular.

D) No tienen significado clínico.

14. Para la evaluación de lo que se conoce como flujo plasmático renal efectivo se utiliza una de las siguientes sustancias:

A) Acidopara-amino-hipúrico.

B) Yodo-hipurato.

C) Fenolftaleína.

D) Amonio.

15.Cuál es el método que recomiendan actualmente todas las guías de práctica clínica para estimar el filtrado

A) El aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas.

B) La estimación a partir de la creatinina sérica, peso y edad por la ecuación de Cockcroft-Gault.

C) La ecuación CKD-EPI obtenida a partir de la creatinina sérica estandarizada.

D) La ecuación MDRD estimada a partir de la concentración de creatinina sérica no estandarizada

16. Señale cuál de los siguientes cilindros suelen encontrarse en pacientes que tienen alteraciones renales:

A) Cilindros de células epiteliales tubulares/cilindros céreos.

B) Cilindros leucocitarios.

C) Cilindros hialinos.

D) Las respuestas A y B son correctas.

17. Para la recogida de una orina de 24 horas, informaremos al paciente:

A) Como tiene que recoger la muestra.

B) Donde tiene que entregar la muestra.

C) No es nuestra función dar este tipo de información.

D) Las respuestas a y b son correctas.

18. En la reacción de Biuret, señale la RESPUESTA CORRECTA:

A) El fundamento de la prueba es que, en presencia de sales de cobre y medio ácido, se forma un compuesto coloreado.

B) En orina muestra escasa sensibilidad.

C) Es un método de cuantificación de lípidos.

D) Es un método refractométrico.

19. ¿Cuál de estos cristales, aparecidos en el sedimento de una orina en el laboratorio de urgencias, es de origen medicamentoso?

A) Cristales de biurato amónico.

B) Cristales de indinavir.

C) Cristales de 2.8 dihidroxiadenina.

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20. Una ingesta excesiva de vitamina C, puede provocar la aparición en el sedimento urinario de:

A) Cristales de Cistina.

B) Cristales de Ácido Úrico.

C) Cristales de Oxalato.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

D) Ninguna es correcta.

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la proteína de Bence Jones es cierta?

A) Son inmunoglobulinas de cadenas pesadas.

B) En las personas sanas no existe esta proteína.

C) Está aumentada en las personas enfermas por hipotiroidismo.

D) Está aumentada en las personas con enfermedad de Addison.

22. En la técnica colorimétrica para la determinación de la creatinina:

A) La creatinina reacciona con el picrato alcalino formando un complejo azulado.

B) La creatinina reacciona con el picrato alcalino formando un complejo rojizo.

C) La creatinina reacciona con el citrato ácido formando un complejo azulado.

D) La creatinina reacciona con el citrato alcalino formando un complejo rojizo.

23. Cuando se detecta proteinuria en una muestra de orina, se debe buscar en el sedimento urinario la presencia de:

A) Cilindros

B) Cristales de oxalato cálcico

C) Leucocitos

D) Bacterias.

24. Observando un sedimento de orina al microscopio óptico, la característica diferencial entre hematíes y leucocitos es:

A) Los leucocitos son de menor tamaño que los hematíes

B) Los hematíes carecen de núcleo

C) Los hematíes se observan de color rojo

D) Los hematíes tienen un aspecto estrellado característico.

25. En un sedimento de orina normal no se debe encontrar:

A) Ningún leucocito

B) Ningún hematíe

C) Células de mucosa externa

D) Cilindros

26. Al observar un sedimento de orina al microscopio, se presentan unos cristales con forma de ataúd. ¿De qué cristales se trata?:

A) Cristales de oxalato cálcico.

B) Cristales de ácido úrico.

C) Cristales de urato amónico.

D) Cristales de fosfato triple.

27. El sistema de filtración de la nefrona es:

A) La cápsula de Bowman.

B) El glomérulo.

C) El sistema tubular.

D) Ninguna es cierta.

28. Los valores normales de la densidad urinaria en una muestra de primera hora de la mañana oscilan entre:

A) 100-200.

B) 500-600.

C) 700-800.

D) 1010-1030.

29. En una nefropatía diabética nos encontraremos niveles de proteínas en orina:

A) Disminuidos.

B) No habrá proteínas en orina.

C) De 7 g/día.

D) De 3 g/día.

30. La presencia de hematíes en orina puede confundirse con otros elementos como:

A) Levadura.

B) Leucocitos.

C) Plaquetas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

D) Pelos.

31. En el estudio microscópico del sedimento urinario señale lo correcto:

A) El uso de contraste de fases es recomendable en la diferenciación de hematíes.

B) Los cristales de colesterol nunca se observan en orina.

C) No existen microscopios específicos para formas cristalinas.

D) En ocasiones podemos buscar cristales en orina de 24 horas.

32. En los análisis de orina señale lo falso:

A) Los cristales de tirosina tiene forma de tapa de ataúd.

B) El pH la orina nos ayuda a identificar cristales en la misma.

C) La acción ureolítica de bacterias, puede generar cristales en orina si se demora análisis.

D) La medida de oxalato nos ayuda a identificar riesgo de litiasis.

33. La orina de 24 h es la más utilizada en:

A) Análisis de rutina.

B) Laboratorios de urgencias.

C) Determinaciones cuantitativas metabólicas.

D) Cultivos microbiológicos.

34. Se pueden producir proteinurias transitorias en:

A) La presencia de fiebre.

B) Situaciones de estrés.

C) La realización de ejercicio físico intenso.

D) En todas las situaciones anteriores.

35. En la muestra para medir proteínas en orina, es cierto que:

A) Una muestra de orina es estable durante 7 días entre dos y ocho grados (2-8°C).

B) Si se precisa congelar, la temperatura debe ser menor o igual a menos 70°C (-70°C).

C) Se debe añadir conservantes a la orina.

D) A y B son ciertas.

36. Las ecuaciones para la estimación del filtrado glomerular (FG), son ejemplos ecuación de Cockcroft-Gault y la ecuación MDRD-4 ("Modification of Diet in Renal Disease"), tratan de obtener una estimación del FG con todos los siguientes excepto:

A) la concentración de creatinina sérica.

B) La concentración de creatinina en orina.

C) Variables antropométricas (peso, talla y etnia).

D) Edad y sexo del paciente.

37. La reacción (observada por cambio de color) en la celulosa de la tira reactiva de orina que utiliza el nitropusiato de sodio, (test de Legal) nos sirve para medir de forma semicuantitativa:

A) Presencia de urobilinógeno.

B) Presencia de hematíes.

C) Presencia de bilirrubina.

D) Presencia de cuerpos cetónicos.

38. La reacción (observada por cambio de color) en la celulosa de la tira reactiva de orina que utiliza el tetraclorofenol-tetrabromosulfotaleína nos sirve para medir de forma semicuantitativa:

A) El pH.

B) Densidad específica.

C) Presencia de proteínas.

D) Presencia de leucocitos.

39. Todos los siguientes métodos son de utilidad para la cuantificación de proteínas en orina, excepto:

A) Turbidimétricos (ácido tricloroacético o cloruro de bencetonio).

B) Inmunofluorescencia indirecta.

C) Nefelométricos

D) Los de fijación a colorantes (Ponceau-S, y rojo de pirogalol molibdato).



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

40. Señale lo cierto de los siguientes hallazgos observados en el sedimento urinario:

- A) Los cristales de ácido úrico son típicos de orinas alcalinas.
- B) Los cristales de fosfato de calcio tienen forma hexagonal.
- C) Las células del epitelio de transición tienen forma variada (piriformes, redondeadas y, en raqueta).
- D) Ninguno es cierto.

41. El término proteinuria "selectiva" indica:

- A) Es la única alteración en la orina
- B) Sólo ocurre en mujeres embarazadas
- C) Es fundamentalmente por proteínas de bajo peso molecular
- D) Sólo hay inmunoglobulinas en la orina

42. En la acidosis tubular renal, el pH de la orina es:

- A) Ácido.
- B) Alcalino.
- C) Neutro.
- D) Variable, dependiendo de la dieta.

43. Un sedimento urinario caracterizado por piuria con bacterias y cilindros leucocitarios, indica:

- A) Síndrome nefrótico.
- B) Pielonefritis.
- C) Enfermedad renal poliquística
- D) Cistitis.

44. El método de la tira reactiva en orina de detección de sangre puede dar positivo con:

- A) Hemoglobina
- B) Hematíes
- C) Mioglobina libre
- D) Todas son correctas

45. ¿Cuál es la estabilidad de la muestra de orina a temperatura ambiente para el análisis de anormales y sedimento?

- A) 24 horas.
- B) 12 horas.

C) 2 horas.

D) Es tal, que se puede procesar al día siguiente de la micción.

46. Las determinaciones semicuantitativas en orina mediante tiras reactivas se basan en:

- A) Potenciometría
- B) Inmunodifusión
- C) Refractancia
- D) Polarimetría

47. Desde el punto de vista estructural la Proteína de Bence Jones se relaciona directamente con:

- A) Moléculas intactas de IgG
- B) Cadenas pesadas
- C) Cadenas ligeras
- D) Porciones de cadenas pesadas con cadenas ligeras

48. La presencia de cilindros céreos en un sedimento urinario indica:

- A) Una enfermedad renal crónica grave.
- B) Una complicación de la Diabetes Mellitus.
- C) Una enfermedad hepática grave.
- D) Una alteración del tiroides.

49. ¿Cuál de las siguientes proteínas que aparece en la orina es más sensible a la reacción con los colorantes de la tira reactiva que mide la proteinuria?

- A) Albúmina
- B) Globulinas
- C) Mucoproteínas
- D) Todas reaccionan con la misma sensibilidad.

50. Aunque la glucosa en orina puede aparecer con diferentes valores de glucosa plasmática, variando según el flujo sanguíneo glomerular, índice de reabsorción tubular y flujo urinario se puede generalizar diciendo que la glucosuria puede aparecer cuando la glucemia es superior a:

- A) 150 mg/dL



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

B) 180 mg/dL

C) 210 mg/dL

D) 240 mg/dL

51. Señale cuál de los siguientes cristales NO SE FORMAN a pH ácido:

A) Uratos amorfos.

B) Oxalato cálcico.

C) Fosfatos amorfos.

D) Tirosina.

52. Respecto a la presencia de hematíes dismórficos en la orina:

A) Suele deberse a errores preanalíticos.

B) Su presencia en un % elevado indica un origen glomerular de la hematuria.

C) Su presencia en un % elevado indica hematuria no glomerular.

D) No tiene significado clínico.

53. La precipitación del ácido úrico se evita si a la orina de 24 horas se le añade:

A) Timol

B) Ácido clorhídrico

C) Hidróxido sódico

D) Cloruro cálcico

54. ¿Cuál de las siguientes proteínas presenta la mayor eficiencia en el diagnóstico de Proteinuria Tubular?

A) Alfa-1 microglobulina

B) Beta-2 microglobulina

C) Cadenas ligeras de las inmunoglobulinas

D) Todas las anteriores.

55. Un paciente que presenta en el sedimento de orina microhematuria, proteinuria y cilindros hemáticos, ¿cuál de los siguientes cuadros patológicos padece?:

A) Lesión glomerular.

B) Lesión tubular.

C) Obstrucción de la vía urinaria.

D) Infección renal.

56. Señale la afirmación correcta en cuanto al análisis de proteínas en orina utilizando tiras reactivas:

A) El área de la tira reactiva es más sensible a globulinas que a albúmina.

B) Un resultado negativo puede descartar la presencia de proteínas.

C) Los resultados deben confirmarse con una prueba más específica para evitar falsos positivos.

D) Los resultados deben confirmarse con una prueba más específica para evitar falsos negativos

57. La presencia en orina de proteínas de bajo peso molecular denota la existencia de:

A) Enfermedad renal crónica secundaria a Diabetes Mellitus.

B) Enfermedad túbulo-intersticial.

C) Proteinuria ortostática.

D) Hipertensión.

58. En sentido descendente, las vías urinarias están formadas por:

A) Pelvis, Uretra, Vejiga y Uréteres.

B) Vejiga, Pelvis, Uretra y Uréteres.

C) Pelvis, Uréteres, Vejiga y Uretra.

D) Uretra, Uréteres, Vejiga y Pelvis.

59. La presencia de cilindros en la orina indica:

A) Un origen vesical.

B) Un origen uretral.

C) Un origen renal.

D) Ninguna es correcta.

60. Determinación a la que se añade a la orina de 24 h 10-12 ml de HCl (pH mantenido a 2-3) para su conservación:

A) Catecolaminas.

B) Creatinina

C) Amilasa.

D) Plomo.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

61. Los cristales de tirosina en la orina tienen forma de:
A) Cruz
B) Hexágonos
C) Acúmulos de agujas
D) Rombos
62. El índice de filtración glomerular en un individuo sano es de aproximadamente:
A) 425 ml/min
B) 225 ml/min
C) 125 ml/min
D) 75 ml/min.
63. Una estersa positiva en una tira reactiva de orina indica:
A) Presencia de bacterias
B) Presencia de hematíes
C) Presencia de leucocitos
D) Cetonuria
64. La concentración elevada de mioglobina en orina, hace sospechar una de las siguientes patologías:
A) Embarazo
B) Infección de orina
C) Rabdomiólisis
D) Pancreatitis
65. Cuando observamos al microscopio un sedimento urinario. ¿Qué forma describen las células del epitelio de transición o procedentes de la vejiga?
A) De forma redondeada y oval y con un gran núcleo central
B) Con forma poligonal o de "raqueta"
C) No se les podría definir con una forma correcta
D) Son células grandes, aplanadas, con un gran citoplasma y un pequeño núcleo.
66. Cuando se detecta proteinuria en una muestra de orina, se debe buscar en el sedimento urinario la presencia de:
A) Cilindros
B) Cristales de oxalato cálcico
C) Leucocitos
D) Bacterias
67. En un examen microscópico del sedimento urinario no se aprecian:
A) Células
B) Cilindros
C) Levaduras
D) Cuerpos cetónicos
68. La proteinuria de Bence-Jones se asocia:
A) Mieloma múltiple
B) Anemia ferropénica
C) Anemia megaloblástica
D) Microcitos
69. Con respecto a la proteinuria de Bence-Jones señale la afirmación incorrecta:
A) Determina la presencia de cadenas ligeras de inmunoglobulinas en orina
B) Se asocia a mieloma múltiple, macroglobulinemia y linfomas malignos
C) La electroforesis y la inmunofijación son los mejores métodos de identificación y cuantificación
D) La presencia de proteína de Bence-Jones es detectada siempre por las reactivas de orina
70. Para la determinación de la densidad de la orina no se utiliza:
A) Urinómetro.
B) Refractómetro.
C) Crioscopio.
D) Tiras reactivas.
71. En el sedimento de una orina con los siguientes valores en sus parámetros bioquímicos: pH = 5.5, Hematíes 300/μl, leucocitos 200/μl, se observan unos cristales incoloros en forma de tapas de ataúd. Señalar cuál será su composición más probable:
A) Fosfato Triple



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

B) Oxalato cálcico

C) Cistina

D) Ninguno de ellos.

72. Señalar la asociación errónea entre analito y conservante en la recogida de orina de 24 horas:

A) Oxalato: ácido clorhídrico

B) Cortisol: Refrigerado

C) Porfirinas: Carbonato sódico

D) Catecolaminas: congelado.

73. Qué proteína se cuantifica en orina junto con la albúmina para determinar el origen tubular de una proteinuria:

A) Beta 2 microglobulina

B) Alfa 2 macroglobulina

C) Proteína C Reactiva.

D) Ninguno de ellos.

74. En un examen sistemático de orina con tira reactiva, aparecen muy positivas la bilirrubina y el urobilinógeno, este perfil es compatible con:

A) Enfermedad hemolítica

B) Obstrucción biliar

C) Enfermedad hepática

D) Insuficiencia renal.

75. Cuando observamos al microscopio u sedimento urinario ¿Qué forma describen las células del epitelio de transición o procedentes de la vejiga?:

A) De forma redondeada u oval y con un gran núcleo central.

B) Con forma poligonal o de "raqueta"

C) no se les podría definir con una forma concreta.

D) Son células grandes, aplanadas, con un gran citoplasma y un pequeño núcleo.

76. Cuando se detecta proteinuria en una muestra de orina, se debe buscar en el sedimento urinario la presencia de:

A) Cilindros.

B) Cristales de oxalato cálcico.

C) Leucocitos.

D) Bacterias.

77. Observando un sedimento de orina al microscopio óptico, la característica diferencial entre hematíes y leucocitos es:

A) Los leucocitos son de menor tamaño que los hematíes.

B) Los hematíes carecen de núcleo.

C) Los hematíes se observan de color rojo.

D) Los hematíes tienen un aspecto estrellado característico.

78. De los siguientes elementos, ¿cuál es anormal en un sedimento de orina?:

A) Glucosa

B) Cilindros hialinos

C) Células escamosas

D) Leucocitos (de 2 a 5 leucocitos/campo)

79. El método de Jaffe está recomendado para la determinación de:

A) Bilirrubina

B) Ácido úrico

C) Creatinina

D) Albúmina

80. La urea es el producto final del metabolismo proteico, se consideran valores normales entre:

A) 1,2 y 5,4 mg/dl

B) 12 y 54 mg/dl

C) 12 y 54 g/dl

D) 50 y 54 g/dl

81. ¿Qué parámetro es mejor que la urea para determinar la función renal?

A) Creatinina

B) Cloro

C) Sodio

D) Calcio

82. La proteinuria de Bence - Jones es:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

- A) La excreción urinaria de cadenas ligeras de inmunoglobulinas.
- B) La presencia de leucina en orina.
- C) La excreción patológica de albúmina.
- D) La presencia de cilindros hialinos en orina.
83. En orinas ácidas se pueden encontrar cristales de:
- A) Carbonato cálcico.
- B) Fosfato amorfo.
- C) Ácido úrico.
- D) Fosfato de calcio.
84. En un análisis de orina, ¿qué parámetro nos indica la presencia de bacterias?:
- A) Glucosa.
- B) Cuerpos cetónicos.
- C) Nitritos.
- D) Proteínas.
85. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la proteína de Bence Jones es cierta?:
- A) Son inmunoglobulinas de cadenas pesadas.
- B) En las personas sanas no existe esta proteína.
- C) Está aumentada en las personas enfermas de hipotiroidismo.
- D) Está aumentada en las personas con enfermedad de Addison.
86. Las células epiteliales halladas en el sedimento urinario pueden ser:
- A) Células epiteliales descamativas.
- B) Células epiteliales de transición.
- C) Células epiteliales redondas.
- D) Hay más de una respuesta correcta.
87. En la técnica colorimétrica para la determinación de la creatinina:
- A) La creatinina reacciona con el picrato alcalino formando un complejo azulado.
- B) La creatinina reacciona con el picrato alcalino formando un complejo rojizo.
- C) La creatinina reacciona con el citrato ácido formando un complejo azulado.
- D) La creatinina reacciona con el citrato alcalino formando un complejo rojizo.
88. La prueba de Griess se utiliza para detectar en orina, la presencia de:
- A) Nitritos.
- B) Cuerpos cetónicos.
- C) Bilirrubina.
- D) Hematíes.
89. Para la lectura automatizada del sedimento urinario se puede utilizar:
- A) Inmunodifusión radial.
- B) Cromatografía.
- C) Microscopía automática sobre orina centrifugada.
- D) Quimioluminiscencia.
90. ¿Qué cristales podemos encontrar en una orina alcalina?
- A) Uratos amorfos.
- B) Cristales de fosfato cálcico.
- C) Cristales de ácido úrico.
- D) Cristales de oxalato cálcico.
91. En la fórmula propuesta, CKD-EPI para la estimación del filtrado glomerular, ¿qué variables forman parte de la ecuación?
- A) Edad y raza
- B) Sexo
- C) Creatinina sérica
- D) Todas las anteriores
92. Ante la sospecha de daño en los túbulos renales, ¿qué parámetro de los que se citan a continuación determinaría en suero?
- A) Beta -microglobulina
- B) Albúmina
- C) pH
- D) Beta-hidroxibutirato



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

93. ¿qué parámetro es mejor que la urea para determinar la función renal?
A) Creatinina
B) Cloro
C) Sodio
D) Calcio
94. ¿Qué determinación utilizaría para identificar una muestra como orina en caso de duda?
A) Sodio y potasio
B) Tira reactiva
C) Fosfato
D) Urea y creatinina
95. Los cilindros granulados gruesos:
A) Aparecen al comienzo de la descomposición celular.
B) Son similares a los hialinos.
C) Son pequeños.
D) Todas son ciertas.
96. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los cristales de ácido úrico es falsa?
A) Presentan tonalidades amarillentas.
B) Aparecen en orinas ácidas.
C) Pueden aparecer en pacientes con gota.
D) Siempre son un indicio de una patología urgente.
97. Respecto a la urea, señale la respuesta incorrecta:
A) Proviene de la destrucción de los aminoácidos formadores de las proteínas.
B) Un método para determinar la urea es la reacción de Berthelot.
C) Disminuye en la insuficiencia renal.
D) Disminuye en personas con poca masa muscular.
98. Un volumen de orina superior a 2000 ml en 24 horas recibe el nombre de:
A) Poliuria
B) Anuria
C) Oliguria
D) Ninguno de los anteriores
99. La prueba BENEDICT, es una prueba para determinar en orina la presencia de:
A) Cetonas
B) Hemoglobina
C) Glucosa
D) Leucocitos
100. La presencia de hemoglobina en orina se denomina:
A) Litiasis
B) Proteinuria
C) Hemoglobinuria
D) Piuria
101. ¿Cuál es la cantidad de orina producida normalmente por un adulto en un día (24 horas)?
A) 0,5 litros
B) 1 litro
C) Entre 1 y 1,5 litros
D) Más de 2 litros
102. La nefrona está compuesta por:
A) Glomérulo, formado por la arteria aferente, eferente y cápsula de Bowman.
B) Tubo contorneado proximal y Asa Henle.
C) Tubo contorneado distal.
D) Todas las anteriores son correctas.
103. La turbidez en la orina puede deberse a:
A) Precipitación de fosfatos en orinas ácidas
B) Precipitación de fosfatos en orinas alcalinas
C) Precipitación de uratos en orinas alcalinas
D) La presencia de cristales no origina turbidez
104. Los cristales de oxalato cálcico en orina son observados en un sedimento de orina:
A) Aparecen normalmente en orinas alcalinas.
B) Aparecen en orinas conservadas cerca de un foco de calor, ya que el calor favorece la cristalización.
C) Tiene forma de rombo.
D) Aparece en condiciones fisiológicas referidas a la ingesta excesiva de determinados alimentos.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

105. La presencia de cuerpos cetónicos en la orina de un diabético:

- A) Indica que se está consumiendo el exceso de glucosa y es buen pronóstico.
- B) No tiene significación clínica.
- C) Indica que se están metabolizando ácidos grasos.**
- D) Ninguna es correcta.

106. La anuria es:

- A) Exceso de diuresis
- B) Diuresis inexistente**
- C) Diuresis normal
- D) Aumento de la diuresis

107. La presencia de nitritos en orina puede indicar:

- A) Presencia de bacterias**
- B) Malabsorción del colesterol
- C) Nefropatías
- D) Mala ingesta

108. La presencia de glucosa en orina se denomina:

- A) Glucemia
- B) Glucosuria**
- C) Glucosanuria
- D) Todas de las anteriores

109. En el sedimento de orinas ácidas podemos encontrar cristales de:

- A) Ácido úrico**
- B) Fosfato amónico magnésico
- C) Biurato amónico
- D) Carbonato cálcico

110. Aparece mioglobina en orina en:

- A) Síndrome de aplastamiento
- B) Infarto de miocardio
- C) Quemaduras
- D) Todas son correctas**

111. El método de Biuret sirve para:

- A) Determinar azúcares
- B) Cuantificar grasas

C) Cuantificar proteínas

D) Cuantificar aminoácidos esenciales

112. En la reacción de Biuret:

- A) Calentamos el compuesto a analizar 180° en medio alcalino y en presencia de Cu++
- B) Los péptidos y las proteínas desarrollan colores diferentes
- C) Necesitamos el reactivo llamado Biuret
- D) Todas son correctas**

113. En la reacción de Biuret el compuesto de cobre (II) que se forma es de color:

- A) Rojo
- B) Azul**
- C) Verde
- D) Amarillo

114. Entre los procesos detectables más fácilmente por estudio químico de la orina están:

- A) Proteinuria
- B) Glucosuria
- C) Cetonuria
- D) Todas son correctas**

115. El signo más frecuente de que existe una enfermedad renal en un estudio de orina es:

- A) Proteinuria**
- B) Glucosuria
- C) Cetonuria
- D) Ninguna es correcta

116. Los cálculos renales más frecuentes son:

- A) Cistina
- B) Ácido úrico
- C) Fosfato amónico magnésico
- D) Oxalato cálcico**

117. El método de EHLRICH se emplea en el análisis de la orina para la detección de:

- A) Glucosa
- B) Bilirrubina



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

C) Urobilinógeno

D) Proteínas

118. El método de ROTHERA se emplea en el análisis de la orina para la detección de:

A) Cuerpos cetónicos

B) Bilirrubina

C) Urobilinógeno

D) Proteínas

119. El riñón filtra aproximadamente en condiciones normales:

A) 1200 ml sangre por minuto

B) 1200 ml orina por minuto

C) 200 ml sangre por minuto

D) 200 ml orina por minuto

120. Si utilizamos conservantes para una orina de 24h:

A) Debemos anotarlo en el tarro.

B) Nunca se deben utilizar conservantes en este tipo de muestra.

C) Siempre usaremos EDTA.

D) Siempre usaremos Oxalato Cálculo.

121. Los hematíes de una muestra de orina se pueden confundir con:

A) Leucocitos

B) Plaquetas

C) Levaduras

D) Bacterias

122. Para tomar una muestra de orina no deberemos:

A) Lavarnos las manos

B) Lavar los genitales con clorhexidina

C) Aclarar los genitales con abundante agua

D) Debemos hacer todo esto

123. El aumento del número de micciones de orina al día se conoce como:

A) Poliuria

B) Polaquiuria

C) Oliguria

D) Anuria

124. Una orina turbia puede ser indicativo de la presencia de:

A) Bacterias

B) Cristales

C) Leucocitos

D) Todas las anteriores

125. ¿Cuál puede ser causa de hemoglobinuria?

A) Lesión renal

B) Anemia hemolítica

C) Ejercicio físico intenso

D) Todas las anteriores

126. La aparición de hilos de moco en una orina:

A) Será siempre por una infección vírica

B) Se puede considerar normal

C) Será por cristales de oxalato cálcico

D) Será por una mala manipulación de la muestra

127. Una proteinuria en personas jóvenes que aparece durante el día y desaparece por la noche se denomina.

A) Falsa

B) Funcional

C) Ortostática

D) Alta

128. Los cuerpos cetónicos provienen de la degradación de ácidos grasos y podemos encontrarlos como:

A) Ácido acetilacético

B) Ácido beta hidroxibutírico

C) Acetona

D) Todas son ciertas

129. Si determinamos la presencia de bilirrubina por el método de azul de metileno la muestra

A) Cambiará de amarilla a azul

B) Cambiará de azul a verde

C) Cambiará de roja a azul

D) Se quedará amarilla si es positiva



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

130. La hemoglobina aparece en orina por:

- A) Degradación de hematíes
- B) De forma normal
- C) Por obstrucción de las vías biliares
- D) Por la creación de cuerpos cetónicos

131. Observando un sedimento de orina el microscopio óptico, la característica diferencial entre hematíes y leucocitos es:

- A) Los leucocitos son de menor tamaño que los hematíes
- B) Los hematíes carecen de núcleo
- C) Los hematíes se observan de color rojo
- D) Los hematíes tiene un aspecto estrellado característico

132. Para el análisis de orina de micción aislada, generalmente se recomienda obtener la muestra de primera hora de la mañana por los siguientes motivos, excepto:

- A) Presenta una menor osmolalidad.
- B) Está más concentrada en elementos químicos.
- C) Está más concentrada en elementos formes.
- D) Está menos influenciada por la dieta.

133. Se define oliguria como:

- A) Un aumento del volumen de orina.
- B) Una disminución del volumen de orina.
- C) Ausencia de producción de orina.
- D) Una disminución de la densidad de la orina.

134. Ante la presencia, en el sedimento urinario, de hematíes dismórficos, se debe sospechar una hematuria de origen:

- A) Vesical.
- B) Uretral.
- C) Glomerular.
- D) Vaginal.

135. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta, respecto a las ecuaciones para la estimación del filtrado glomerular?

- A) Son una medida indirecta del aclaramiento de creatinina.
- B) Son útiles en los casos en que la recogida de orina de 24 horas sea dificultosa.
- C) La más utilizada en adultos es la ecuación de Schwartz.
- D) Sobrestiman la filtración glomerular a niveles bajos.

136. ¿Qué tipo de cristales esperarías encontrar, en el examen microscópico de una orina con pH alcalino?

- A) Fosfato amónico magnésico.
- B) Oxalato cálcico.
- C) Ácido úrico.
- D) Tirosina.

137. La reacción de Brand en orina (cian nitroprusiato sódico) sirve para la detección de:

- A) Glicosaminoglicanos.
- B) Cistina.
- C) Porfirinas.
- D) Fenilpirúvico.

138. La cistatina C es un marcador de utilidad en la valoración de:

- A) El filtrado glomerular.
- B) Anemia asociada a procesos crónicos.
- C) Proceso inflamatorio agudo.
- D) Insuficiencia cardiaca.

139. Una de las siguientes es causa de uremia post-renal:

- A) Dieta baja en proteínas.
- B) Hipertrofia benigna de próstata.
- C) Glomerulonefritis post-estreptocócica.
- D) Ayuno extremo

140. La presencia de glucosuria con cifras normales de glucosa en sangre es posible en:

- A) Diabetes mellitus tipo 1.
- B) Diabetes mellitus tipo 2.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

C) Embarazo.

D) Diabetes MODY.

141. El resultado de la sangre en una tira reactiva de orina es positiva, pero en el sedimento no se observan eritrocitos, esto puede ser debido a la presencia de:

A) Cilindros granulosos.

B) Bacterias.

C) Cristales de ácido úrico.

D) Ácido ascórbico.

142. ¿Cuál es la estabilidad de la muestra de orina a temperatura ambiente para el análisis de anormales y sedimento?

A) 24 horas.

B) 12 horas.

C) 2 horas.

D) Es tal, que se puede procesar al día siguiente de la micción.

143. Desde el punto de vista estructural la Proteína de Bence Jones se relaciona directamente con:

A) Moléculas intactas de IgG

B) Cadenas pesadas

C) Cadenas ligeras

D) Porciones de cadenas pesadas con cadenas ligeras

144. En el seguimiento de la diabetes mellitus, ¿cuál es la prueba más adecuada para detectar un fallo renal tempranamente?

A) Glucosuria

B) Cetonuria

C) Microalbuminuria

D) Proteinuria

145. Señala qué tipo de proteinuria se caracteriza por la pérdida renal de albúmina y grandes cantidades de globulinas de alto Peso Molecular; alfa-2 macroglobulina, IgG y Transferrina.

A) Proteinuria glomerular selectiva.

B) Proteinuria glomerular no selectiva.

C) Proteinuria tubular.

D) Proteinuria por sobreproducción o rebosamiento.

146. Sobre contaminantes y elementos formes de la orina que pueden dificultar o confundir en la observación del sedimento, señale la proposición FALSA:

A) Restos de cremas pueden ser confundidos con cilindros céreos.

B) Fibras textiles pueden ser confundidas con levaduras.

C) Trichomonas vaginalis inmóviles en las que no se aprecie flagelo pueden parecer leucocitos.

D) Gránulos de polen o esporas de hongos pueden ser desconocidos para observadores no expertos.

147. ¿Cuál de las siguientes inmunoglobulinas no aparece en orina procedente del filtrado glomerular?:

A) Proteinuria de Bence-Jones.

B) IgA.

C) IgG.

D) IgM.

148. ¿Cuál es la ecuación recomendada para la estimación del Filtrado Glomerular en niños (2 a 18 años) según el Documento de Consenso (2013) de la SEQC y la Asociación Española de Nefrología Pediátrica (AENP)?:

A) Ecuación MDRD-4 o MDRD-IDMS si la medida de creatinina presenta trazabilidad respecto al método de referencia.

B) Ecuación CKD-EPI, si la medida de creatinina se realiza con métodos con trazabilidad y enzimáticos.

C) Ecuación MDRD para métodos de medida de creatinina sin trazabilidad.

D) Ecuación de Schwartz-IDMS para métodos de medida de creatinina con trazabilidad



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

149. La orina de un paciente muestra en la tira reactiva los siguientes resultados: bilirrubina (++) y urobilinógeno indetectable. Estos resultados son más compatibles con:

- A) Hemólisis.
- B) Hepatitis vírica.
- C) Colestasis.
- D) Hiperbilirrubinemia no conjugada.

150. La osmolalidad de una solución solo depende de:

- A) El número de partículas en solución.
- B) El tamaño de las moléculas en solución.
- C) La carga de los iones en solución.
- D) El tamaño de los iones en solución.

151. En qué propiedad coligativa están basados los métodos recomendados para la medida de la osmolalidad en plasma y orina:

- A) Disminución de la presión de vapor.
- B) Disminución del punto de congelación.
- C) Aumento del punto de ebullición.
- D) Aumento de la presión de vapor

152. Un color blanco turbio en la orina, en el contexto de formación de cristales, puede deberse a una:

- A) Precipitación de uratos en orinas alcalinas.
- B) Precipitación de fosfatos en orinas acidas.
- C) La presencia de cristales NO provoca turbidez.
- D) Precipitación de fosfatos en orinas alcalinas.

153. Los nitritos en orina (señale la RESPUESTA CORRECTA):

- A) Su presencia implica hematuria
- B) Se liberan en la lisis de los neutrófilos
- C) Suelen estar normalmente
- D) Su presencia implica bacteriuria

154. ¿Cuál de los siguientes elementos pueden afectarse si una orina permanece expuesta a la luz algún tiempo?

- A) Células
- B) Cilindros

C) Urobilinógeno

D) Glucosa

155. En referencia a la recogida de orina, indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) Generalmente se recomienda recoger la primera orina de la mañana.
- B) Si se demora la entrega al laboratorio tras su recogida, la muestra debe estar refrigerada entre 2-8 °C.
- C) En la recogida de orina de 24 h, se recogerá toda la orina del primer día, desde la primera obtenida de la mañana durante las 24 h siguientes, hasta la primera del segundo día que se desechará.
- D) En pacientes pediátricos se deben usar bolsas colectoras con adhesivos hipoalergénicos.

156. ¿Qué cristales predominan en las orinas básicas?

- A) Fosfatos amónico-magnésico
- B) Oxalatos cálcico
- C) Urato
- D) De ácido úrico

157. ¿Qué magnitudes debemos tener en cuenta para una correcta evaluación de la función renal?

- A) Troponina, urea, proteínas totales y amonio.
- B) Glucosa, urea, troponina y proteínas totales.
- C) Amilasa, creatinina, proteínas totales y urea.
- D) Urea, creatinina, ácido úrico y amonio.

158. Los cilindros presentes en el sedimento urinario son un signo de:

- A) Aumento de proteínas.
- B) Aumento de densidad.
- C) Su presencia en el sedimento no tiene significación clínica.
- D) Son las células más abundantes del sedimento urinario.

159. Respecto a los nitritos en orina:

- A) Si existe bacteriuria tiene que haber nitritos (+).



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

B) Algunas bacterias son capaces de transformar los nitratos a nitritos.

C) Indican hematuria.

D) Indican presencia de levaduras.

160. En la identificación de cristales en orina ¿qué parámetro nos orienta?

A) pH

B) Densidad

C) Proteínas

D) Presencia de bacteriuria

161. Sobre los cilindros hialinos:

A) El componente es la proteína de Tamm-Horsfall.

B) Su forma es cilíndrica con sus extremos irregulares.

C) Aparecen solamente en orinas anormales con pH alcalino.

D) Los cilindros hialinos no son transparentes.

162. La aparición de cuerpos cetónicos en la orina puede indicar entre otras cosas:

A) Estado de desnutrición

B) Insuficiencia renal

C) Carecen de significado clínico

D) Nitritos positivos

163. Para realizar una correcta recogida de orina de 24 horas:

A) Se desecha la primera micción del día, y a partir de ahí, recoge toda la orina de ese día hasta las 12 pm.

B) Se recoge la orina desde la primera micción del día hasta la primera micción de la mañana siguiente.

C) Se desecha la primera micción del día, y a partir de ahí, se recoge toda la orina de ese día, incluida la primera micción de la mañana siguiente.

D) Se recoge la orina desde la primera micción del día y se desecha la primera micción de la mañana siguiente.

164. Es falso que los cristales de cistina, en un examen microscópico de orina:

A) Se encuentren en orinas ácidas

B) Tengan forma de placas hexagonales

C) Sean insolubles en amoníaco

D) Sean insolubles en ácido acético

Explicación: recordar que bases diluyen a ácidos y viceversa.

165. ¿Cuál de los siguientes cristales predominan en orinas alcalinas?

A) Brushita

B) Oxalato cálcico

C) Uratos

D) Tiroxina

166. Es una característica de los cilindros hialinos en un sedimento urinario:

A) Extremos afilados

B) Aspecto rugoso

C) Configuración lisa

D) Composición cerea

167. En relación a los cilindros urinarios, ¿cuál de las siguientes es INCORRECTA?

A) La matriz primitiva está constituida por la proteína de Tamm-Horsfall.

B) Los cilindros hialinos no son transparentes.

C) No deben aparecer en orina, aunque en algunas situaciones no patológicas pueden aparecer cilindros hialinos.

D) Durante la formación del cilindro pueden quedar atrapados elementos formes de la orina, que dan lugar a los tipos de cilindros.

168. El concepto de aclaramiento renal es artificial, pero es válido para expresar matemáticamente:

A) La cantidad de una sustancia eliminada por el riñón en un tiempo dado.

B) La eliminación de un volumen determinado de líquido en un tiempo dado.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

C) El volumen plasmático, del cual el riñón elimina por completo una sustancia en un tiempo dado.

D) La capacidad de secreción del sistema renal.

169. Un sedimento urinario caracterizado por piuria con bacterias y cilindros leucocitarios generalmente indican:

A) Síndrome nefrótico.

B) Pielonefritis.

C) Enfermedad renal poliquística

D) Síndrome nefrítico.

170. En una muestra de orina, señale cuál de los siguientes cristales no se forman a pH ácido:

A) Uratos amorfos.

B) Oxalato cálcico.

C) Fosfatos amorfos.

D) Ácido úrico.

171. ¿En cuál de las siguientes enfermedades renales es más frecuente la descripción de una proteinuria intensa (excreción de más de 3,5 g/ 24 h)?:

A) Síndrome nefrótico.

B) Glomerulonefritis.

C) Amiloidosis renal.

D) Esclerosis renal.

172. ¿Qué test es utilizado en el laboratorio de urgencias para una detección rápida de porfobilinógeno en una orina de micción aislada?:

A) Test de O'Sullivan.

B) Test de Hoesch.

C) Test de Apgar.

D) Test de Coombs.

173. ¿Cuál de las siguientes determinaciones en orina de 24 horas requiere acidificación?:

A) Urea

B) Creatinina

C) Catecolaminas.

D) Proteínas totales.

174. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los cilindros y hialinos es falsa?

A) Están formados por proteínas y material mucoide.

B) Todas son falsas.

C) Presentan longitud variable y bordes regulares.

D) Cursan con orina que presentan glucosuria.

175. Si le realizamos una determinación de la cetonuria por medio de la tira reactiva el cuadradito se valora de color

A) Púrpura.

B) Azul.

C) Amarillo.

D) Rojo.

176. Si en orina recién emitida aparece turbidez puede ser debida a

A) Presencia elevada de bacteria.

B) Alteraciones del PH.

C) Presencia de una cantidad elevada de hematíes.

D) Cualquiera de estas circunstancias pueden originar turbidez.

177. Un PH por debajo de los valores normales puede ser indicio de

A) Infección urinaria.

B) Diabetes.

C) Aumento de proteínas.

D) Todas son falsas.

178. En referencia a la recogida de orina muestra para análisis bioquímico, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

A) Generalmente se recomienda recoger la primera orina de la mañana.

B) Si se demora la entrega en el laboratorio tras su recogida, la muestra debe estar refrigerada entre 2-8°C.

C) En pacientes pediátricos se deben usar bolsas colectoras con adhesivos hipoalergénicos.

D) Todas son correctas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

179. En una muestra de orina ácida podemos encontrar cristales de:

- A) Carbonato de calcio.
- B) Oxalato de calcio.**
- C) Fosfato triple.
- D) Fosfatos de calcio.

180. Señale cuáles de los siguientes datos son necesarios para realizar el cálculo del filtrado glomerular:

- A) Edad, sexo y creatinina.**
- B) Colesterol, altura y peso.
- C) Colesterol, pH y creatinina.
- D) Peso, edad y triglicéridos.

181. La cantidad de proteína excretada por la orina de 24 horas en un sujeto sano es:

- A) Superior a 300 mg.
- B) Inferior a 150 mg.**
- C) Entre 250 y 300 mg.
- D) Entre 200 y 250 mg.

182. En una muestra de orina la presencia de nitritos indica:

- A) Hematuria.
- B) Lisis de los neutrófilos.
- C) Su presencia es habitual en una orina normal.
- D) Bacteriuria.**

183. Indique cuál de las siguientes puede ser una característica macroscópica de las muestras:

- A) Cilindros.
- B) PH.
- C) Fórmula leucocitaria.
- D) Color.**

184. Los valores normales de densidad urinaria en una muestra de primera hora de la mañana oscilan entre:

- A) 100-200.
- B) 500-600.
- C) 700-800.

D) 1010-1030.

185. ¿Por qué suele emplearse la primera muestra de orina de la mañana para el análisis rutinario de la misma?:

- A) Por haber permanecido en reposo el individuo.
- B) Por ser la más concentrada.**
- C) Por ser la más diluida.
- D) Por ser la menos contaminada.

186. La presencia de proteínas en orina se llama:

- A) Glucosuria.
- B) Proteinuria.**
- C) Cetonuria.
- D) Hemoglobinuria.

187. Señale cuál es el recorrido en el orden correcto de la orina en el cuerpo humano, desde que se forma la orina hasta que se expulsa al exterior:

- A) Riñón, uréter, uretra y vejiga.
- B) Riñón, uréter, vejiga y uretra.**
- C) Riñón, vejiga, uréter y uretra.
- D) Riñón, uretra, vejiga y uréter.

188. Una técnica empleada habitualmente para la determinación de proteínas en orina es:

- A) Fotometría de llama.
- B) Fluorimetría.
- C) Refractometría.
- D) Turbidimetría.**

189. La orina de 24 horas es la más utilizada en el laboratorio clínico de:

- A) Urgencia.
- B) Toxicología.
- C) Bioquímica del metabolismo intermedio.**
- D) Microbiología.

190. ¿A qué se atribuye el olor característico de la orina?:

- A) A la cantidad de iones circulantes en orina.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

B) A la presencia de metabolitos inactivos de la peroxidasa.

C) A la presencia de cloro en la composición de la orina.

D) A la presencia de ácidos volátiles.

191. ¿Qué tipo de cristales esperarías encontrar en el examen microscópico de una orina con pH alcalino?:

A) Fosfato amónico magnésico.

B) Oxalato cálcico.

C) Ácido úrico.

D) Tirosina.

192. ¿Qué es la osmolaridad?

A) Es el número de osmoles de soluto en 1 kg de disolvente

B) Es el número de osmoles de soluto en 1 L de disolución

C) Es el número de osmoles de diluyente en 1 kg de disolución

D) Es el número de osmoles de diluyente en 1 L de disolución

193. ¿Cuáles son los cilindros urinarios con mayor índice de refracción?

A) Granulosos.

B) Céreos.

C) Hialinos.

D) Hemáticos.

194. La turbidez en la orina puede deberse a:

A) Precipitación de uratos en orinas alcalinas

B) Precipitación de fosfatos en orinas ácidas

C) Precipitación de fosfatos en orinas alcalinas

D) Presencia de cristales

195. Cuando observamos al microscopio un sedimento urinario, ¿qué forma tienen las células del epitelio de transición?

A) Forma redondeada u oval y con un gran núcleo central.

B) Forma poligonal

C) Forma aplanada con un gran citoplasma y un pequeño núcleo

D) No tienen una forma concreta.

196. Respecto a la cristaluria, señale la respuesta correcta:

A) El ácido úrico puede cristalizar en orinas alcalinas o neutras.

B) Los cristales de oxalato cálcico generalmente aparecen en orinas ácidas o pH neutro.

C) Los cristales de fosfatos amorfos generalmente se observan en orinas ácidas.

D) Los cristales de fosfato cálcico son muy frecuentes encontrarlos en orina normal ácida o neutra.

197. La orina normal es débilmente aromática, pero si una orina tiene un olor afrutado es clásico de:

A) Ácido acético.

B) Ácido bórico.

C) Alteración del pH.

D) Acidosis diabética con acetonuria.

198. En la mayoría de equipos de urianálisis la tecnología que se emplea es:

A) Inmunocromatografía.

B) Inmunoanálisis con detección enzimática.

C) Espectrofotometría de luminiscencia.

D) Espectrofotometría de reflectancia.

199. Ante la presencia, en el sedimento urinario, de hematíes dismórficos, se debe sospechar una hematuria de origen:

A) Vesical.

B) Uretral.

C) Glomerular.

D) Vaginal.

200. La determinación de sangre por tiras reactivas detecta:

A) Hematíes intactos.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

- B) Hemoglobina.
- C) Mioglobina libre.
- D) Todas ellas.

201. ¿Cómo se debe recoger la orina a un bebé?:

- A) Directamente en copa graduada.
- B) Colocando al niño semisentado.
- C) No se puede recoger orina a un bebé.
- D) Previo lavado de la zona perineal, colocar la bolsa estéril de plástico.

202. ¿Qué miden las pruebas de aclaramiento renal?:

- A) Los mililitros de orina liberada de una sustancia eliminada por el riñón en la unidad de tiempo.
- B) Los mililitros de orina que elimina el riñón en un minuto.
- C) Los mililitros de sangre que serían liberados de una sustancia eliminada por el riñón en la unidad de tiempo.
- D) Los mililitros de sustancia eliminada por el riñón en un minuto.

203. ¿Qué tipo de cristales NO aparecen en orinas ácidas?:

- A) Uratos amorfos.
- B) Ácido úrico.
- C) Carbonato cálcico.
- D) Oxalato cálcico.

204. ¿Cómo se observan las células del epitelio escamoso en el sedimento urinario?

- A) con núcleo pequeño redondo, citoplasma extenso y aspecto poligonal.
- B) células pequeñas y redondeadas.
- C) aparecen en raras ocasiones y son difíciles de identificar.
- D) poseen núcleo grande, casi igual al citoplasma.

205. ¿Qué dos pruebas bioquímicas determinarían que un líquido biológico sea muy probablemente orina?

- A) Glucosa y cuerpos cetónicos.

- B) Urea y creatinina.
- C) Ácido úrico y urea.
- D) Creatinina y ácido úrico.

206. Al observar la muestra de heces del paciente al microscopio detectamos un tipo de cristales típicos con forma de ataúd, indique de cual se trata:

- A) De fosfato amónico magnésico.
- B) De Charcot - Leyden.
- C) De colesterol.
- D) De oxalato amónico.

207. ¿Qué parámetro no se considera de urgencia para valorar la función renal?

- A) Sodio en suero.
- B) Urea en suero.
- C) Ácido úrico en suero.
- D) Creatinina sérica.

208. La principal causa de interferencia en una muestra de orina sin conservante y conservada a temperatura ambiente durante más de 2 horas, es:

- A) Concentración de los analitos.
- B) Sedimentación celular.
- C) Proliferación bacteriana.
- D) Formación de cristales.

209. En relación a la recogida de orina de 24 horas, ¿cuál es verdadera?

- A) Se puede recoger según considere el paciente, pero solo durante 24 horas.
- B) Solo es de utilidad para confirmar la presencia o ausencia de un analito.
- C) Es necesaria para cuantificar analitos que varían en función del metabolismo corporal.
- D) No es imprescindible cuantificar el volumen de la muestra recogida.

210. Indique cómo se encuentran las fracciones proteicas en el síndrome nefrótico:

- A) Aumentadas.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

B) Disminuidas.

C) Unas aumentadas y otras disminuidas.

D) Sin cambios.

211. En el estudio elemental de orina mediante tiras reactivas determinamos la presencia de cuerpos cetónicos. ¿Cuál es uno de ellos?

A) Ácido etanodioico.

B) Ácido glucurónico.

C) Ácido hipúrico.

D) Ácido hidroxibutírico.

212. Las proteínas de masa muscular, formada por aminoácidos del tipo glicina, arginina y metionina, se excretan como:

A) Urea.

B) Creatinina.

C) Ácido úrico.

D) Glucosa.

213. ¿Cuál de las siguientes partes NO pertenece a la nefrona?

A) Glomérulo.

B) Cápsula de Bowman.

C) Válvula sigmoide.

D) Tubos contorneados.

214. La cetonuria es:

A) Aparición de cuerpos cetónicos detectables en orina.

B) Ausencia de cuerpos cetónicos en orina.

C) Disminución de glucosa en orina.

D) Ausencia de cuerpos cetónicos en sangre.

215. Las diferentes estructuras que pueden ser observadas en el sedimento urinario, incluyen:

A) Diferentes tipos de células.

B) Cilindros.

C) Cristales.

D) Todas son ciertas.

216. ¿Cuál es la ecuación para la estimación de la filtración glomerular en población pediátrica?

A) Ecuación de Cockcroft-Gault.

B) Ecuación del estudio MDRD.

C) Ecuación de Schwartz.

D) Ninguna es correcta.

217. La anuria corresponde a:

A) Aumento del volumen de orina.

B) Disminución del volumen de orina.

C) Práctica anulación de la producción de orina.

D) Densidad fija.

218. ¿Cuál de estas patologías no corresponde a orinas blanquecinas o lechosas?

A) Porfirinurias.

B) Piurias graves.

C) Quilurias.

D) Hiperoxaluria.

219. La reacción de Ehrlich ¿Para qué parámetro bioquímico de medición con la tira reactiva de orina se utiliza?

A) Glucosa.

B) Cuerpos cetónicos.

C) Urobilinógeno.

D) Bilirrubina.

220. ¿Cuál de estos cristales es predominante en orinas ácidas?

A) Oxalato cálcico monohidratado.

B) Hidroxiapatita.

C) Fosfato ácido de calcio.

D) Fosfato amónico-magnésico

221. La glucosa en orina:

A) Siempre aparece en personas diabéticas.

B) Aparece si la concentración de glucosa en sangre es mayor de 180 mg/dl.

C) Depende del filtrado glomerular.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

222. ¿Qué tipo de cristales podríamos encontrar en el sedimento urinario de una orina con un pH de 6,9?:

A) Cristales de ácido úrico, de oxalato cálcico y uratos amorfos.

B) Cristales de ácido úrico, fosfatos amorfos y fosfato triple.

C) Cristales de ácido úrico, fosfato de calcio y biurato de amonio.

223. ¿Cuál de los siguientes metabolitos no es estable en orina y requiere la adición previa de conservantes al recipiente de recogida?:

A) Proteínas.

B) Catecolaminas.

C) Bilirrubina.

224. ¿Qué parámetro nuevo podemos encontrar en las tiras de orina de once determinaciones?

A) Proteína/creatinina.

B) Creatinina/proteína.

C) Albúmina/proteína.

D) Albúmina/creatinina.

225. Para el cálculo de la osmolalidad en suero necesitamos saber los valores de:

A) Sodio, glucosa y urea.

B) Sodio, glucosa y creatinina.

C) Sodio, potasio y creatinina.

D) Potasio, glucosa y creatinina

226. ¿Qué parámetro no encontraremos en una tira de orina?

A) Bacterias.

B) Glucosa.

C) Leucocitos.

D) Proteínas

227. En un sedimento de orina, qué cristales de los siguientes no encontraremos si la orina es ácida:

A) Cristales de cistina.

B) Cristales de carbonato cálcico.

C) Cristales de ácido úrico.

D) Todos aparecen en orinas ácidas.

228. ¿Qué sustancia es indicativa de infección bacteriana en orina cuando aparece en las correspondientes muestras?

A) Albúmina.

B) Ácido beta-hidroxibutírico.

C) Creatinina.

D) Nitritos.

229. ¿Cómo se observan al microscopio los cristales de oxalato cálcico en el sedimento urinario?

A) Incoloros con forma de prismas de tres a seis caras semejantes a un ataúd.

B) Incoloros con forma de sobre de carta.

C) Amarillentos con formas de haces.

D) Amarillentos con forma de gotas con una cruz típica en su interior al observarse con luz polarizada.

230. ¿Qué parámetros resultan elevados generalmente en la enfermedad renal al hacer una analítica?

A) Urea, creatinina.

B) Amilasa, lipasa.

C) Lactato, piruvato.

D) Triglicéridos, colesterol.

231. ¿Cómo se denomina la concentración de solutos en milimoles por volumen en un litro de disolución?

A) Osmolaridad.

B) Osmolalidad.

C) Dilución.

D) Disolución.

232. ¿Cuáles son los cristales predominantes en la orina ácida?

A) Hidroxiapatita y carboxiapatita.

B) Fosfato ácido de calcio o brushita.

C) Fosfato amónico magnésico o estruvita.

D) Cristales de oxalato cálcico, ácido úrico, uratos.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

233. ¿Qué se necesita para el aclaramiento de la creatinina?

- A) Orina reciente y orina de 24 horas.
- B) Orina de 48 horas y suero.
- C) Orina de 24 horas y plasma citratado.
- D) Orina de 24 horas y suero.**

234. ¿Qué puede indicar la presencia de cilindros en la orina?

- A) Origen vesical.
- B) Origen uretral.
- C) Origen renal.**

235. En la orina se pueden observar cristales de ácido úrico con forma de:

- A) Aspecto de bipirámide tetragonal o sobre de carta.
- B) Aspecto de esfera espiculada.
- C) Aspecto romboidal, rectángulo o prisma.**

236. En la orina se pueden observar cristales de colesterol con forma de:

- A) Bipirámide tetragonal o sobre de carta.
- B) Placas con bordes irregulares.**
- C) Prismas aciculados.

237. ¿Cuál es la glicoproteína que puede formar parte de la matriz de un cilindro?

- A) Alfa 2 macroglobulina
- B) Proteína de Tamm-Horsfall.**
- C) Proteína de Bence-Jones.

238. ¿Cuál es el fundamento teórico de la medición de las tiras reactivas en el análisis sistemático de orina?

- A) Inmunoturbidimetría
- B) Inmunocromatografía
- C) Enzimo-inmunoensayo
- D) Fotometría de reflectancia**

239. La densidad de la orina está aumentada en presencia de:

- A) Diabetes insípida
- B) Glucosuria**
- C) Hiperaldosteronismo
- D) Insuficiencia suprarrenal

240. ¿Cuál de los siguientes cristales no está presente en orinas ácidas?

- A) Wewellitita
- B) Ácido úrico
- C) Estruvita**
- D) Weddellitita

241. Tras un análisis microscópico de una orina con pH ácido, podemos encontrarnos con cristales de:

- A) Fosfato amónico magnésico.
- B) Carbonato cálcico.
- C) Fosfatos amorfos.
- D) Uratos amorfos.**

242. La proteinuria de Bence-Jones se asocia a:

- A) Anemia ferropénica.
- B) Anemia Megaloblástica.
- C) Mieloma Múltiple.**

243. En una muestra de orina con proteinuria, ¿qué debe buscarse en el sedimento urinario?

- A) Leucocitos
- B) Bacterias
- C) Cilindros**
- D) Hematíes

244. En una orina con pH de 5.4, ¿qué tipo de cristales "en forma de diamante" puede encontrar?

- A) Triple fosfato
- B) Oxalato cálcico dihidratado**
- C) Cistina
- D) Oxalato cálcico monohidratado

245. Puede observar hiperdescamación de células transicionales en el sedimento urinario en las siguientes patologías:

- A) Cistitis



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

- B) Glomerulopatías
- C) Cálculos
- D) A y C son correctas**

246. Indique que técnica es utilizada en el laboratorio para detectar la presencia de Hidratos de Carbono reductores en orina:

- A) Método de la Hexoquinasa
- B) Determinación de Microalbuminuria
- C) Método de Benedict**
- D) Método de Biuret

247. Decimos que los cristales que aparecen en orina con aspecto que se asemeja a una "tapa de ataud" son:

- A) Cristales de fosfato triple.**
- B) Cristales de oxalato cálcico.
- C) Uratos.
- D) Leucina.

248. ¿Qué técnica de espectroscopia se emplea fundamentalmente en el análisis de cálculos renales?

- A) Absorción atómica.
- B) Atomización en llama.
- C) Emisión atómica.
- D) Infrarrojo.**

249. La presencia de proteínas en orina se denomina:

- A) Glucosuria.
- B) Proteinuria.**
- C) Cetonuria.
- D) Hemoglobinuria

250. ¿Cuál es el volumen diario medio de orina en un adulto sano?

- A) Superior a 2000 ml.
- B) < 400 ml.
- C) De 1200 a 1500 ml.**
- D) 600 ml.

251. Paciente de 3 años que acude a urgencias de Pediatría y cuya madre, muy nerviosa, consulta por bajo peso y orinas "amarillas". La exploración clínica del niño no muestra ningún dato de interés. Los resultados del análisis de orina son:

- pH= 6'0 (RANGO NORMAL= 5'5-6'5)
 - Densidad= 1020 (RANGO NORMAL= 1015-1025)
 - Glucosa= Positivo (RANGO NORMAL= Indetectable)
 - Cuerpos Cetónicos= Negativo (RANGO NORMAL= Negativo)
 - Nitritos= Negativo (RANGO NORMAL= Negativo)
 - Leucocitos= Negativo (RANGO NORMAL= Negativo)
 - Hemoglobina= Negativo (RANGO NORMAL= Negativo)
- Ante esta situación, ¿qué actitud adoptaría si los resultados del análisis de sangre fueran rigurosamente normales?

- A) Recomendaría realizar un cultivo de orina por la alta sospecha de posible infección urinaria.
- B) Recomendaría cuantificar proteínas en orina para descartar un cuadro febril.
- C) No haría nada porque los resultados son compatibles con la normalidad.**
- D) Sospecharía una diabetes insípida por tener la densidad baja.

252. El fundamento teórico del análisis del sistemático de orina es:

- A) Inmunoturbidimetría.
- B) Nefelometría.
- C) Fotometría de reflectancia.**
- D) Enzimoimmunoensayo.

253. En el caso de que la paciente tenga infección de orina, ¿qué pruebas del sistemático de orina deberían dar positivos?

- A) Glucosa.
- B) Nitritos.
- C) Leucocitos.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

D) Las respuestas B) y C) son correctas.

254. ¿Qué utilidad tiene la introducción del nuevo parámetro combinado Albúmina/Creatinina?

- A) Controlar la proteinuria.
- B) Diagnosticar nuevos diabéticos.
- C) Cribar la presencia de Microalbuminuria.
- D) No está demostrada su utilidad analítica.

255. En una plataforma de orinas ideal, ¿qué elemento NO debe figurar?

- A) Analizador sistemático de orina.
- B) Módulo óptico de sedimento.
- C) Módulo de tinción.
- D) Módulo de almacenamiento.

256. El estudio de la orina puede aportar información clínica sobre:

- A) Alteraciones del equilibrio ácido-base.
- B) Infecciones por bacterias, hongos o parásitos.
- C) Enfermedades metabólicas.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

257. ¿Qué tipo de cristales podremos encontrar en una orina alcalina?

- A) Cristales de ácido úrico.
- B) Cristales de leucina.
- C) Cristales de cistina.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

258. Para la determinación de aclaramiento de creatina se requiere:

- A) Orina elemental.
- B) Orina de 24 h.
- C) Muestra de sangre.
- D) Las respuestas B) y C) son correctas.

259. ¿En qué principio se basa la determinación de osmolalidad en orina?

- A) Cromatografía líquida de alta resolución
- B) Isoelectroenfoque
- C) Descenso del punto de congelación

- D) Sin una osmolaridad en suero, no tiene significación clínica
- E) Todas son falsas

260. En el caso de que la paciente tenga infección de orina, ¿qué pruebas del sistemático de orina deberían dar positivos?

- A) Glucosa y nitritos
- B) Hematíes y glucosa
- C) Leucocitos y nitritos
- D) Hematíes y cuerpos cetónicos
- E) Glucosa y cuerpos cetónicos

261. ¿En una IRC que alteraciones bioquímicas se observan?:

- A) Aumento niveles de creatinina, urea y niveles iónicos.
- B) Aumento de los niveles de creatinina y urea y disminución de niveles de potasio.
- C) Disminución de los niveles de creatinina, urea y sodio.
- D) Aumento de niveles de creatinina y urea, aumento de niveles de potasio.
- E) Disminución de niveles de creatinina y urea, aumento de niveles de potasio

262. Los cilindros hemáticos en un sedimento urinario:

- A) Son formaciones proteicas de hematíes y leucocitos.
- B) Son formaciones proteicas en cuyo interior se han quedado atrapados hematíes.
- C) Son hematíes con morfología anormal.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

263. ¿En qué principio se basa la determinación de osmolalidad en orina?

- A) Cromatografía líquida de alta resolución.
- B) Isoelectroenfoque.
- C) Descenso del punto de congelación.
- D) Turbidimetría.

264. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

A) Se puede descartar una infección urinaria, puesto que los nitritos son negativos.

B) No hay otras patologías que puedan ocasionar hematuria, aparte de la infección urinaria.

C) La esterasa leucocitaria solo detecta la presencia de leucocitos intactos.

D) La prueba de hematíes de la tira reactiva detecta hematíes, hemoglobina (hematíes lisados) y mioglobina.

265. Señale cuál es el recorrido, en el orden correcto, de la orina en el cuerpo humano, desde que se forma hasta que es expulsada al exterior:

A) Riñón, uréter, uretra y vejiga.

B) Riñón, uréter, vejiga y uretra.

C) Riñón, vejiga, uréter y uretra.

D) Riñón, uretra, vejiga y uréter.

266. ¿Cuál de estos factores, según la preparación del paciente, repercuten en el resultado de la osmolaridad en orina?

A) No guardar 12 horas de ayuno desde la cena del día anterior.

B) Fumar más de 10 cigarrillos el día anterior.

C) Esta prueba no necesita preparación.

267. En el síndrome nefrótico:

A) Se perderán las proteínas de menor tamaño y se retendrán las de mayor tamaño.

B) Las proteínas totales no se verán afectadas.

C) Se observa una hipogammaglobulinemia.

268. ¿Qué parámetro NO encontraremos en una tira de orina?

A) Bacterias.

B) Leucocitos.

C) Glucosa.

269. Una de los siguientes productos es fotosensible y, por lo tanto, el recipiente que lo contenga debe ser opaco o protegido de la luz, indique cuál:

A) Catecolaminas.

B) Factor VII.

C) Vitamina B 12.

270. En el análisis del sedimento de una orina se observan cilindros de tamaño variable, con hendiduras en los bordes, tonalidades amarillentas y alto índice de refracción. ¿Qué tipo de cilindro responde a esta descripción?

A) Hialino.

B) Céreo.

C) Granuloso.

271. Si en un sedimento de orina vemos cristales de cistina, ¿qué pH tiene la orina?

A) Ácido.

B) Alcalino.

C) Neutro.

272. Al hablar de la turbidez en una muestra de orina, es cierto que:

A) La presencia de uratos (turbidez rosácea) se muestra en orinas alcalinas.

B) La presencia de elementos formes tales como leucocitos, eritrocitos, etc. no afectan a la turbidez del espécimen.

C) La orina turbia es un signo inequívoco de patología renal.

D) Una orina turbia no es necesariamente patológica.

273. Sobre las características físicas de la orina, es cierto que:

A) La densidad es más baja en la primera orina de la mañana.

B) La oliguria se asocia típicamente a la Diabetes mellitus.

C) En la isostenuria se producen variaciones considerables de la densidad.

D) La incapacidad para concentrar o diluir la orina es una característica de enfermedad renal.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

274. En la observación al microscopio del sedimento de orina, se observan algunas células de unos 13-20 μm , redondeadas, que presentan un núcleo visible y centrado que ocupa casi la mitad del citoplasma ligeramente granuloso. ¿Qué son?

- A) Células epiteliales planas de epitelio escamoso. Son células que se encuentran con gran frecuencia.
- B) Células de epitelio de transición o de vías urinarias. Es normal observar la presencia de 1 célula /campo 40x, y algo más en niños y ancianos.**
- C) Células epiteliales renales o células epiteliales tubulares. Son las células que conforman el epitelio monoestratificado que tapiza los túbulos renales. La presencia de 1 célula /campo 40x suele significar daño tubular.

275. En el sedimento de una orina ácida, ¿Qué cristales no encontraremos?

- A) Cristales de ácido úrico.
- B) Cristales de tirosina.
- C) Cristales de cistina.
- D) Cristales de urato amónico.**

276. En el uso de conservantes para orina de 24 horas, señale la relación incorrecta entre el conservante y el analito:

- A) Ácido clorhídrico para determinación de ácido vanilmandélico.
- B) Carbonato sódico para determinación de porfirinas.
- C) Ácido clorhídrico para determinación de porfobilinógeno.**
- D) Ácido acético para determinación de ácido homovanílico.

277. ¿Por qué se suele emplear la primera muestra de orina de la mañana para el análisis rutinario de la misma?

- A) Por haber permanecido en reposo el individuo.
- B) Por ser la orina más concentrada.**
- C) Por ser la orina más diluida.
- D) Por ser la orina menos contaminada.

278. La excreción diaria (24 h) de orina en un adulto es de media:

- A) 1200 y 1500 ml.**
- B) 900 y 1100 ml.
- C) 950 y 1000 ml.
- D) 500 y 1000 ml.

279. En el sedimento urinario, ¿qué tipo de cilindros tienen aspecto refringente, homogéneo y con los bordes definidos?

- A) Hialino.
- B) Céreo.**
- C) Granuloso.
- D) Epitelial tubular.

280. La medida de la osmolalidad de la orina:

- A) Es una medida de la concentración más exacta que la densidad.**
- B) Depende tanto del número como de la naturaleza de las partículas en disolución.
- C) Se realiza generalmente en el análisis de orina rutinario.
- D) Consiste en medir el número de osmoles que hay en 100 ml de disolución.

281. Cuando se detecta proteinuria en una muestra de orina, se debe buscar en el sedimento urinario la presencia de:

- A) Bacterias.
- B) Cristales de oxalato cálcico.
- C) Leucocitos.
- D) Cilindros.**

282. En las determinaciones cuantitativas de proteínas, azúcares y otros elementos constitutivos de la orina:

- A) Se prefiere una muestra bastante diluida.
- B) Basta generalmente que la muestra haya sido evacuada en condiciones normales.
- C) Se recomienda una muestra cogida de la mitad de la micción.
- D) Lo más adecuado es una recogida de 24 horas.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

283. En el sedimento de orina alcalina normal no podemos observar cristales de:

- A) Fosfato cálcico.
- B) Cistina.**
- C) Fosfato amónico magnésico.
- D) Carbonato cálcico.

284. ¿En qué situación clínica se puede encontrar una proteinuria transitoria?

- A) Síndrome nefrótico idiopático.
- B) Glomerulonefritis aguda postinfecciosa.
- C) Insuficiencia cardíaca.**
- D) Nefropatía membranosa.

285. En la orina la identificación adecuada de los cristales es esencial para no pasar por alto los que se asocian con varias condiciones patológicas y poder confirmar el diagnóstico correcto. Muchos de los cristales observados, tienen morfologías y características propias. Indique la afirmación falsa:

- A) Los cristales provocados por la administración de ampicilina por dosis altas son incoloros con aspecto de prismas largos que forman racimos, gavillas y dan un pH ácido.
- B) Los cristales de biurato de amonio dan el aspecto de orina “vieja” de color amarillo oscuro o marrón con esferas o “manzanas espinosas” (esferas con cuernos) que da un pH alcalino.
- C) Los cristales de tirosina son incoloros o amarillentos, aparece negro al enfocar; con un pH alcalino y la forma característica es en finas agujas sedosas agrupadas en gavillas o rosetas.**
- D) Los cristales de cistina son incoloros, con un pH ácido, presentan formas de placas hexagonales, a menudo laminadas, rápidamente destruidas por bacterias; puede confundirse con ácido úrico, pero la cistina es soluble en ácido clorhídrico diluido

286. ¿Cuál de los siguientes cristales tiene importante significación clínica?

- A) Tirosina.**
- B) Fosfato triple.

- C) Fosfato cálcico.
- D) Biurato amónico

287. La proteína de Tamm-Horsfall:

- A) Su concentración sérica se encuentra elevada en alteraciones glomerulares.
- B) No es una proteína encontrada en personas.
- C) Es una glucoproteína secretada por las células tubulares renales.**
- D) Su defecto induce la formación de cristales de oxalato cálcico en orina.

288. Un sedimento urinario, con hematíes dismórficos y pequeños, presencia de cilindros hemáticos y acantocitos será muy indicativo de:

- A) Glomerulonefritis aguda y crónica.**
- B) Síndrome nefrótico.
- C) Pielonefritis.
- D) Urolitiasis.

289. Intensa proteinuria, acompañada de hipoalbuminemia y de la observación en el sedimento de células tubulares con cuerpos ovals grasos, así como, frecuentes gotas lipídicas libres, es característico de:

- A) Pielonefritis.
- B) Síndrome nefrótico.**
- C) Síndrome de Fanconi.
- D) Necrosis tubular.

290. Con respecto a la presencia de bilirrubina en la tira de orina, señale la respuesta INCORRECTA;

- A) La bilirrubina indica la presencia en orina de bilirrubina conjugada.
- B) El hallazgo de bilirrubina en orina tiene significado patológico.
- C) El hallazgo de urobilinógeno en orina tiene menos importancia diagnóstica que el de bilirrubina.
- D) En obstrucciones mecánicas del ciclo enterohepático aparece una elevación importante de bilirrubina no conjugada en orina.**



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

291. ¿Cuál de los siguientes tipos de elementos formes no aparece en el sedimento urinario de enfermos con síndrome nefrótico?

- A) Cilindros hialinos.
- B) Cilindros granulados.
- C) Cuerpos grasos ovales y lipoides.
- D) Hematíes.**

292. De los métodos de medida de la creatinina, ¿Cuál es el de mayor exactitud?

- A) Jaffé.
- B) Jaffé cinético modificado.
- C) Jaffé cinético compensado.
- D) Enzimático.**

293. ¿Con cuál de los siguientes parámetros correlaciona mejor la excreción de creatinina?:

- A) Dieta.
- B) Edad.
- C) Masa muscular.**
- D) Peso corporal.

294. En el estudio de la enfermedad glomerular renal es frecuente la solicitud de hematíes dismórficos; dentro de este grupo se encuentran los acantocitos o células G1, cuyo valor indicativo de lesión glomerular es:

- A) $\geq 5\%$.**
- B) $\geq 3\%$.
- C) $\geq 2\%$.
- D) $\geq 1\%$.

295. Una de las siguientes características NO corresponde a una hematuria glomerular:

- A) Tonalidad pardo-oscuro, tipo "coca-cola".
- B) Aparecen mayoría de hematíes isomórficos.**
- C) Ausencia de coágulos.
- D) Acompañado de proteinuria.

296. Sobre el fundamento de la determinación de la osmolalidad en el osmómetro de punto de congelación, indicar la respuesta incorrecta:

A) El descenso del punto de congelación es proporcional al número de partículas en la disolución.

B) La muestra se debe enfriar a una temperatura aproximada de -7°C .

C) La temperatura del baño hace que se congele la muestra y la sonda térmica detecta el calor de fusión que se absorbe y que es proporcional al descenso del punto de congelación.

D) Tras la congelación se libera el calor de fusión provocando una elevación de temperatura hasta el punto en que coexisten muestra sólida y líquida en equilibrio en el punto de congelación.

297. ¿En qué parte de la nefrona se realiza la mayor parte de la reabsorción renal del agua filtrada en el glomérulo?

- A) En el túbulo distal.
- B) En el asa de Henle ascendente.
- C) En el túbulo colector.
- D) En el túbulo proximal.**

298. Respecto a los cuerpos cetónicos, es FALSO que:

- A) Son: acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona.
- B) Se sintetizan en el hígado.
- C) Son utilizados como fuente energética por el cerebro, en ausencia de glucosa.
- D) En condiciones normales, se sintetizan en grandes cantidades para el consumo del cerebro.**

299. ¿Cuál de estos no es un factor que incrementa la posibilidad de daño renal?

- A) Diabetes.
- B) HTA.
- C) Litiasis renal.**
- D) Edad avanzada.

300. ¿Qué tinción utilizaremos para el estudio del sedimento urinario si queremos observar la morfología general de los microorganismos?

A) Tinción de Sternheimer-Malbin.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

B) Tinción con Sudán III.

C) Tinción de eosina.

D) Tinción de azul de metileno.

301. Si en un examen microscópico de orina nos encontramos con cristales incoloros, con forma de sobre de carta o de formas octaédricas, ¿de qué están compuestos?

A) Ácido úrico.

B) Uratos amorfos.

C) Ácido hipúrico.

D) Oxalato cálcico.

302. El método de Nessler es:

A) Un método a punto y final.

B) Un método para determinar la concentración de urea.

C) a) y b) son correctas.

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

303. El uromucoide es:

A) Una proteína.

B) Una hormona.

C) Un cristal.

D) Un cilindro.

304. Una de las siguientes determinaciones NO se obtiene en un análisis de orina convencional:

A) Nitritos.

B) Cuerpos cetónicos.

C) Troponina.

D) Proteínas.

305. Señale, de los productos finales del metabolismo, cuál NO pertenece a los compuestos nitrogenados no proteicos.

A) Creatinina.

B) Ácido láctico.

C) Urea.

D) Ácido úrico.

306. ¿Qué situación podemos relacionar con altos niveles de urobilinógeno urinario sin bilirrubina en la orina?

A) Exposición a toxinas hepatotóxicas.

B) Enfermedad de Dubin-Jonson.

C) Anemia hemolítica.

D) Piedras en el conducto biliar.

307. En la proteinuria glomerular, el patrón electroforético de orina muestra:

A) Un bajo porcentaje de albúmina.

B) Un gran número de fracciones séricas de elevado peso molecular.

C) Una elevación de albúmina.

D) Un aumento de la concentración total de proteínas.

308. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los cristales de ácido úrico es falsa?

A) Presentan tonalidades amarillentas.

B) Aparecen en orinas ácidas.

C) Pueden aparecer en pacientes con gota.

D) Siempre son un indicio de una patología urgente.

309. La precipitación con ácido tricloroacético se utiliza para determinar en orina:

A) Proteínas.

B) Azúcares reductores.

C) Urobilinógeno.

D) Cuerpos cetónicos.

310. El movimiento de sustancias del lumen de la nefrona a los capilares renales o intersticio se denomina:

A) Excreción

B) Filtración

C) Reabsorción

D) Secreción

311. Las tiras reactivas para la determinación de pH en orina presentan como indicador:

A) Azul B.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

- B) Verde jano.
- C) Ocre pouch.
- D) Rojo metilo.**

312. ¿Qué nos indica la presencia de cilindros céreos en un sedimento de orina?

- A) Infección de orina
- B) Normalidad
- C) Consumo de drogas
- D) Daño renal grave**

313. Son indicadores ácido-base:

- A) Rojo Congo, azul de bromocresol, fenoltaleína, azul de timol**
- B) Piruvato, naranja de metal, rojo Congo
- C) Azul de bromocresol, naranja de metilo, rojo Congo y tinta china
- D) Rojo Congo, azul de bromocresol, fenoltaleína, azul de timol y piruvato

314. ¿Qué tipo de cilindros pueden encontrarse en caso de deshidratación y que no indican patología nefrológica en ausencia de proteinuria, en condiciones normales en las orinas?

- A) Cilindros leucocitarios y cilindros hemáticos
- B) Cilindros hialinos y cilindros granulosos**
- C) Cilindros epiteliales y cilindros céreos
- D) Cilindros amiloides y Cilindroides

315. La osmolalidad se emplea para evaluar alteraciones en la hidratación y en el diagnóstico diferencial de oligurias. ¿Qué valores normales se estiman en adultos?:

- A) 200 a 220 mOsm/L
- B) 300 a 1200 mOsm/kg**
- C) 200 a 220 mOsm/kg
- D) 300 a 1200 mOsm/L

316. La urea se sintetiza en:

- A) La vejiga.
- B) El riñón.
- C) El intestino.

D) El hígado.

317. El método de Nessler es:

- A) Un método a punto y final.
- B) Un método para determinar la concentración de urea.
- C) a) y b) son correctas.**
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

318. Los hematíes hinchados se encuentran en medios:

- A) Ácidos.
- B) Hipertónicos.
- C) Básicos.
- D) Hipotónicos.**

319. El aumento de urea en sangre puede deberse a:

- A) Embarazo
- B) Situaciones de hemodilución
- C) Fallo hepático
- D) Catabolismo proteico excesivo**

320. El sistema de análisis más común en los análisis químicos de orina (tiras reactivas) en sistemas automatizados se basan en:

- A) Espectrometría de dispersión de partículas
- B) Refractometría
- C) Espectrometría de fluorescencia
- D) Fotometría de reflectancia**

321. Los cristales siguientes predominan en orinas alcalinas excepto:

- A) Fosfato amónico-magnésico o estruvita
- B) Oxalato cálcico dihidratado**
- C) Fosfato ácido de calcio o brushita
- D) Hidroxiapatita y carboxiapatita

322. Sabemos que el color de la orina es amarillo ámbar, pero si tiene una coloración verdosa, ¿a qué es debido?

- A) Presencia de cuerpos cetónicos.
- B) Infección de las vías urinarias.**
- C) Presencia de metahemoglobina.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 3: Orina y función renal

D) Colesterol elevado.

323. El servicio de recepción de muestras deberá rechazar una orina cuando:

- A) Venga debidamente etiquetada e identificada.
- B) Que se haya recogido tras lavar los genitales.
- C) Que venga de un niño pequeño y haya sido recogida en bolsa de polietileno.
- D) Cuando venga en cualquier recipiente con tapadera.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases